



RUMAH SAKIT  
PRIMA HUSADA

**LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN  
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG  
TRIWULAN II**

**TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Insiden Keselamatan Bulan April hingga Juni Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada Malang. Seperti yang kita pahami bahwa nafas dari *Patient Safety* adalah belajar (*learning*) dari KTD yang terjadi untuk selanjutnya disusun langkah-langkah agar kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat/unit yang sama maupun di tempat/unit yang lain di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien.

Salah satu program utama dalam penerapan Keselamatan Pasien adalah pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan ini akan menggerakkan berbagai proses lanjutan seperti analisis terhadap Insiden dan akibat-akibatnya, penemuan berbagai penyebab, solusinya, dan implementasi. Pelaporan insiden dan proses-proses lanjutan tersebut merupakan jawaban yang paling tepat terhadap keberadaan KTD / KNC / KTC / KPCS, sehingga diharapkan statistic KTD / KNC ini dapat ditekan, dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Dengan tersusunya Laporan Insiden Keselamatan Pasien ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistematis dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 1

DAFTAR ISI.....2

BAB I PENDAHULUAN ..... 3

    1.1    Latar Belakang..... 3

    1.2    Tujuan..... 3

BAB II PELAPORAN INSIDEN ..... 2

    2.1    Pengumpulan Data Insiden Berdasarkan Kategori PMKP 9 ..... 2

    2.2    Data Ketidaksesuaian Diagnosis Pra Operasi Dan Pasca Operasi Bulan Januari-Juni Tahun 2026 ..... 3

    2.3    Data Kejadian Reaksi Transfusi ..... 4

    2.4    Data Kejadian Infeksi ..... 4

    2.5    Data Insiden Keselamatan Pasien Rs Prima Husada Periode Bulan April-Juni Tahun 2026..... 2

    2.6    Rekap Insiden Keselamatan Pasien TW II Tahun 2026 RS Prima Husada Malang Berdasarkan Jenis Kejadian..... 6

    2.7    Grafik Insiden Keselamatan Pasien TW II Tahun 2026 RS Prima Husada Malang Berdasarkan Hasil Grading IKP..... 7

    2.8    Grafik Insiden Keselamatan Pasien TW II Tahun 2026 RS Prima Husada Malang ..8

BAB III PENUTUP ..... 12

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi RS Kemenkes (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Salah satu program utama dalam penerapan Keselamatan Pasien adalah pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan ini akan menggerakkan berbagai proses lanjutan seperti analisis terhadap Insiden dan akibat-akibatnya, penemuan berbagai penyebab, solusinya, dan implementasi. Pelaporan insiden dan proses-proses lanjutan tersebut merupakan jawaban yang paling tepat terhadap keberadaan KTD / KNC / KTC / KPCS, sehingga diharapkan statistik KTD / KNC ini dapat ditekan, dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Laporan Insiden Keselamatan pasien ini dibuat agar kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat/unit yang sama maupun di tempat/unit yang lain di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien.

#### **1.2 Tujuan**

Tujuan Umum

- a. Menurunnya Insiden Keselamatan pasien (KTD, KNC, KTC, dan KPC)
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan Keselamatan pasien

Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien rumah sakit.
- b. Diketahui penyebab Insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalah.
- c. Didapatkan pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama dikemudian hari.

**BAB II**  
**PELAPORAN INSIDEN**

**2.1 PENGUMPULAN DATA INSIDEN BERDASARKAN KATEGORI PMKP 9**

| No    | Kategori                                                                                                                                                                                                            | Insiden                                  | Jumlah |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 1.    | Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi                                                                                                                                                                      | Timbul demam setelah dilakukan transfusi | 1      |
| 2.    | Semua kejadian serius akibat reaksi obat ( <i>adverse drug reaction</i> ) yang serius sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit                                                                                       | Tidak ada insiden                        | 0      |
| 3.    | Semua kesalahan pengobatan ( <i>medication error</i> ) yang signifikan sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit                                                                                                      | Kesalahan pemberian obat                 | 5      |
|       |                                                                                                                                                                                                                     | Kesalahan input e-resep                  | 1      |
|       |                                                                                                                                                                                                                     | Kesalahan penulisan etiket               | 2      |
|       |                                                                                                                                                                                                                     | Kesalahan penyiapan obat                 | 2      |
| 4.    | Semua perbedaan besar antara diagnosis pra dan diagnosis pascaoperasi; misalnya diagnosis praoperasi adalah obstruksi saluran pencernaan dan diagnosis pascaoperasi adalah ruptur aneurisme aorta abdominalis (AAA) | Tidak ada insiden                        | 0      |
| 5.    | Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi procedural tanpa memandang cara pemberian                                                                                               | Tidak ada insiden                        | 0      |
| 6.    | Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi tanpa memandang cara pemberian                                                                                                          | Tidak ada insiden                        | 0      |
| 7.    | Kejadian tidak diharapkan yang berkaitan dengan identifikasi pasien                                                                                                                                                 | Tidak ada insiden                        | 0      |
| 8.    | Kejadian – kejadian lain, misalnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan atau wabah penyakit menular                                                                                                    | Tidak ada insiden                        | 0      |
| Total |                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 11     |

**Analisis:**  
Pada periode Triwulan II Tahun 2026, terdapat 11 insiden yang memenuhi kriteria pemantauan. Insiden paling banyak berasal dari kesalahan pengobatan (*medication error*) yang terdiri dari kesalahan pemberian obat, kesalahan input e-resep, kesalahan penulisan etiket, dan kesalahan penyiapan obat. Dari hasil pemantauan, terdapat 5 insiden kesalahan pemberian obat, 1 insiden kesalahan input e-resep, 2 insiden kesalahan penulisan etiket, dan 2 insiden kesalahan penyiapan obat. Tingginya kejadian medication error menunjukkan masih terdapat celah pada proses pengelolaan obat mulai dari tahap peresepan, verifikasi, penyiapan, hingga pemberian obat kepada pasien. Faktor yang berpotensi berkontribusi antara lain ketidaktepatan petugas, kurang optimalnya proses double check, beban kerja, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kesalahan.

Selain medication error, terdapat 1 kejadian reaksi transfusi yang telah terkonfirmasi berupa timbulnya demam setelah transfusi. Kejadian ini telah dikenali dan ditindaklanjuti sesuai

prosedur pemantauan reaksi transfusi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien. Adanya kejadian reaksi transfusi pada periode triwulan II harus menjadi perhatian agar kejadian tidak berulang lagi.

Pada kategori lainnya, yaitu kejadian serius akibat reaksi obat (adverse drug reaction), perbedaan besar antara diagnosis pra dan pascaoperasi, kejadian tidak diharapkan selama sedasi prosedural maupun nonprosedural, kejadian terkait identifikasi pasien, serta kejadian lain seperti infeksi terkait pelayanan kesehatan atau wabah penyakit menular, tidak ditemukan insiden selama periode pelaporan.

Secara keseluruhan, hasil pemantauan menunjukkan bahwa area prioritas perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan keamanan penggunaan obat (medication safety) melalui penguatan proses verifikasi resep, optimalisasi penggunaan SIMRS/e-resep, peningkatan kepatuhan double check, supervisi berkala, serta edukasi petugas terkait keselamatan penggunaan obat guna menurunkan angka kejadian medication error pada periode berikutnya.

2.2 DATA KETIDAKSESUAIAN DIAGNOSIS PRA OPERASI DAN PASCA OPERASI  
BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2026

| No | Bulan    | Jumlah Operasi |      | Jumlah Ketidaksesuaian |
|----|----------|----------------|------|------------------------|
|    |          | Elektif        | Cito |                        |
| 1  | Januari  | 349            | 24   | 0                      |
| 2  | Februari | 311            | 50   | 0                      |
| 3  | Maret    | 269            | 56   | 0                      |
| 4  | April    | 339            | 45   | 0                      |
| 5  | Mei      | 280            | 75   | 0                      |
| 6  | Juni     | 335            | 52   | 0                      |

**Kesimpulan:**  
Tidak ada kejadian ketidaksesuaian diagnosis pra operasi dan pasca operasi yang terjadi pada Bulan April sampai Juni 2026.

**Analisis:**

- Selama Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan 926 tindakan operasi, terdiri dari 754 operasi elektif dan 172 operasi cito.
- Jumlah operasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 387 tindakan, sedangkan terendah pada bulan Mei sebanyak 355 tindakan.
- Hasil pengukuran menunjukkan tidak terdapat ketidaksesuaian antara diagnosis praoperasi dan diagnosis pascaoperasi pada seluruh tindakan operasi yang dilakukan selama periode April–Juni 2026, sehingga capaian indikator mencapai **100%**.
- Capaian ini menunjukkan bahwa proses penegakan diagnosis sebelum operasi telah dilakukan dengan baik melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta evaluasi klinis yang adekuat dan berhasil dipertahankan dari Triwulan I sampai Triwulan II.
- Tidak adanya ketidaksesuaian diagnosis mencerminkan ketepatan pengambilan keputusan klinis dan koordinasi yang baik antara dokter operator, DPJP, dan unit penunjang.
- Hasil ini menunjukkan mutu pelayanan bedah yang baik serta mendukung keselamatan pasien dalam proses pelayanan operatif.
- Meskipun capaian telah mencapai 100%, monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- Mempertahankan pelaksanaan asesmen praoperasi secara komprehensif sesuai standar dan pedoman yang berlaku.
- Memastikan pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi klinis untuk mendukung ketepatan diagnosis sebelum operasi.
- Melaksanakan audit rekam medis dan evaluasi kesesuaian diagnosis praoperasi dan pascaoperasi secara berkala.
- Mempertahankan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara dokter operator, dokter penanggung jawab pasien, dan unit penunjang.
- Melakukan pembahasan kasus dan kegiatan ilmiah secara berkala untuk mempertahankan kompetensi tenaga medis dalam penegakan diagnosis dan perencanaan tindakan operasi.
- Melakukan monitoring indikator secara rutin sebagai upaya menjaga mutu pelayanan

bedah dan keselamatan pasien.

2.3 DATA KEJADIAN REAKSI TRANSFUSI

| No | Bulan    | Jumlah Kejadian Reaksi Transfusi | Jumlah Transfusi |
|----|----------|----------------------------------|------------------|
| 1  | Januari  | 0                                | 55               |
| 2  | Februari | 0                                | 63               |
| 3  | Maret    | 0                                | 47               |
| 4  | April    | 0                                | 52               |
| 5  | Mei      | 1                                | 34               |
| 6  | Juni     | 0                                | 37               |

Kesimpulan:

Terdapat 1 kejadian reaksi transfusi yang terjadi pada Bulan Januari sampai Juni 2026, yakni pada Bulan Mei.

Analisis:

- Ditemukan 1 kejadian reaksi transfusi selama periode April sampai Juni 2026. Capaian ini meningkat dari periode sebelumnya di mana tidak ada kejadian reaksi transfusi selama periode Triwulan I.
- Kejadian ini menyebabkan capaian indikator menurun dibandingkan Triwulan I Tahun 2026 yang tidak terdapat kejadian reaksi transfusi.
- Hasil investigasi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan transfusi, mulai dari identifikasi pasien, pemeriksaan kesesuaian darah, pelaksanaan transfusi, hingga pemantauan kondisi pasien selama dan setelah transfusi.
- Meskipun jumlah kejadian relatif rendah, reaksi transfusi tetap menjadi kejadian yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan pasien.
- Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi berulang dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur transfusi yang aman.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan investigasi dan pembahasan kasus reaksi transfusi untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan peluang perbaikan.
- Memastikan pelaksanaan identifikasi pasien dan verifikasi kesesuaian darah sebelum transfusi sesuai dengan standar yang berlaku.
- Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemantauan pasien selama dan setelah pemberian transfusi.
- Melakukan edukasi dan refreshment kepada tenaga kesehatan terkait tata laksana transfusi darah yang aman serta penanganan reaksi transfusi.
- Melaksanakan audit kepatuhan prosedur transfusi secara berkala.
- Melakukan monitoring dan evaluasi indikator reaksi transfusi secara rutin sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

2.4 DATA KEJADIAN INFEKSI

| NO | HAIs                                          | Bulan   |         |         |         |         |         |
|----|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                               | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | Mei '26 | Jun '26 |
| 1  | IDO (Infeksi Daerah Operasi)                  | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 2  | VAP (Ventilation Associated Pneumonia)        | 0 ‰     | 0 ‰     | 1.82%   | 0%      | 0%      | 0%      |
| 3  | ISK (Infeksi Saluran Kencing)                 | 0 ‰     | 0 ‰     | 0.81%   | 0%      | 0%      | 0%      |
| 4  | Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis) | 0,35%   | 0,3%    | 0,17%   | 0.33%   | 0,32%   | 0,07%   |

---

**Analisis:**

1. Infeksi Daerah Operasi (IDO)
  - Selama periode April–Juni 2026 tidak ditemukan kejadian IDO (0%) di setiap bulannya.
  - Pada Triwulan I maupun Triwulan II, angka IDO tetap 0%, menunjukkan bahwa penerapan pencegahan infeksi pada tindakan operasi telah berjalan dengan baik dan konsisten.
  - Kepatuhan terhadap prosedur aseptik, pemberian antibiotik profilaksis, sterilisasi alat, dan perawatan luka operasi perlu terus dipertahankan.
2. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
  - Pada Triwulan I ditemukan satu kejadian VAP pada bulan Maret sebesar 1,82%, sedangkan bulan Januari dan Februari tidak ditemukan kasus.
  - Pada Triwulan II tidak ditemukan kasus VAP (0%) selama tiga bulan berturut-turut.
  - Dibandingkan Triwulan I, capaian Triwulan II menunjukkan perbaikan karena berhasil menurunkan angka VAP menjadi nol kasus.
3. Infeksi Saluran Kencing (ISK)
  - Pada Triwulan I ditemukan satu kejadian ISK pada bulan Maret sebesar 0,81%, sedangkan Januari dan Februari tidak ditemukan kasus.
  - Pada Triwulan II tidak ditemukan kejadian ISK (0%) selama periode April–Juni 2026.
  - Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap bundle pencegahan ISK, khususnya dalam pemasangan dan perawatan kateter urin.
4. Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis)
  - Pada Triwulan I angka phlebitis sebesar 0,35%, 0,30%, dan 0,17%, dengan rata-rata 0,27%.
  - Pada Triwulan II angka phlebitis sebesar 0,33%, 0,32%, dan 0,07%, dengan rata-rata 0,24%.
  - Meskipun terjadi peningkatan pada bulan April dan Mei dibandingkan bulan Maret, angka phlebitis menurun signifikan pada bulan Juni sehingga rata-rata Triwulan II lebih rendah dibandingkan Triwulan I.
  - Capaian ini menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan perawatan akses intravena dan penerapan prinsip aseptik.
5. Kesimpulan
  - Secara keseluruhan terdapat perbaikan capaian HAIs pada Triwulan II dibandingkan Triwulan I.
  - Tidak ditemukan kasus IDO, VAP, dan ISK pada Triwulan II.
  - Rata-rata angka phlebitis juga menurun dari 0,27% pada Triwulan I menjadi 0,24% pada Triwulan II.
  - Hasil tersebut menunjukkan efektivitas program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang telah dilaksanakan rumah sakit.

**Rencana Tindak Lanjut:**

1. Melakukan monitoring dan audit kepatuhan bundle pencegahan VAP, ISK, dan IDO secara rutin pada unit pelayanan terkait.
2. Mempertahankan kepatuhan petugas terhadap kebersihan tangan, penggunaan APD, dan penerapan teknik aseptik sesuai SPO.
3. Melakukan evaluasi dan umpan balik berkala kepada unit pelayanan terkait hasil surveilans HAIs setiap bulan.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pemasangan, perawatan, dan pelepasan akses intravena untuk menurunkan angka phlebitis.
5. Melaksanakan refreshment atau edukasi berkala kepada tenaga kesehatan mengenai bundle pencegahan infeksi dan patient safety.
6. Mengoptimalkan peran IPCN dan IPCLN dalam kegiatan surveilans, monitoring, serta pembinaan kepatuhan di unit pelayanan.
7. Mempertahankan capaian nihil kasus IDO, VAP, dan ISK melalui pengawasan berkelanjutan dan tindak lanjut segera terhadap setiap temuan ketidaksesuaian.



## 2.5 DATA INSIDEN KESELAMATAN PASIEN RS PRIMA HUSADA PERIODE BULAN APRIL-JUNI TAHUN 2026

| No. | Tanggal    | Kronologi                                                                                                                                                                                                                                  | IKP  | Grade | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 06/04/2026 | Bidan salah menginput data di kematian maternal yang seharusnya di kematian abortus di web MPDN, sehingga data yang diisi sesuai dengan KTP Ibu.                                                                                           | KTC  | Biru  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaporkan ke Kemenkes RI sehingga data kematian maternal sudah dihapus.</li> <li>- Dilakukan input kematian abortus.</li> <li>- Penyampaian kesalahan input di aplikasi kepada pasien dan suami pasien oleh MOD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | 11/04/2026 | Kesalahan penulisan etiket obat antara antibiotik dan obat anti nyeri sehingga pasien tidak menghabiskan antibiotik yang seharusnya dihabiskan                                                                                             | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengecekan ulang etiket setelah di print.</li> <li>- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check).</li> <li>- Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | 12/04/2026 | Kesalahan cara pemberian obat injeksi. Perawat memberikan obat kepada pasien anak dengan cara dibolus, seharusnya obat pekat diberikan secara didrip, sehingga anak menangis. Lalu keluarga komplain karena infus tiba-tiba menetes cepat. | KTC  | Hijau | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (a) Pendokumentasian perintah DPJP dalam pemberian obat terutama untuk jenis injeksi kepada pasien anak-anak. (b) Jika cara pemberian obat belum jelas dan perawat ragu-ragu atau bingung, boleh bertanya ke DPJP. (c) Refreshing 5B pemberian obat. (d) Memberikan informasi yang detail dan jelas termasuk pemberian obat saat operan shift.</li> <li>2. Perawat senior harus mendampingi perawat baru setiap melakukan tindakan ke pasien.</li> <li>3. (a) KIE kepada keluarga pasien terutama pasien anak, jika infus menetes cepat, bisa memberitahu perawat. (b) Menggunakan prosedur yang benar saat membenahi tetesan infus.</li> <li>4. Masukan dari dr. Heru, jika terjadi komplain, boleh meminta DPJP untuk menjelaskan ke keluarga pasien, agar lebih membuat tenang.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan komite keperawatan</li> </ul> |
| 4.  | 14/04/2026 | Kesalahan penulisan form SBAR karena perawat copy paste advice DPJP di WA tanpa melakukan pengecekan ulang identitas pasien sehingga form SBAR yang tertulis di e-RM adalah milik pasien lain.                                             | KPCS | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM</li> <li>- Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.  | 16/04/2026 | Kejadian kesalahan pemberian antibiotik karena staf farmasi kurang teliti menyiapkan obat. Perawat IRNA hanya double check di etiket tapi tidak di obatnya sehingga tidak                                                                  | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengecekan ulang/verifikasi obat sesuai SPO Verifikasi Pemberian Obat Rawat Inap dan pelaksanaan 5 benar telaah obat (Benar Pasien, Benar Obat, Benar Dosis, Benar Rute, Benar Waktu Pemberian)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

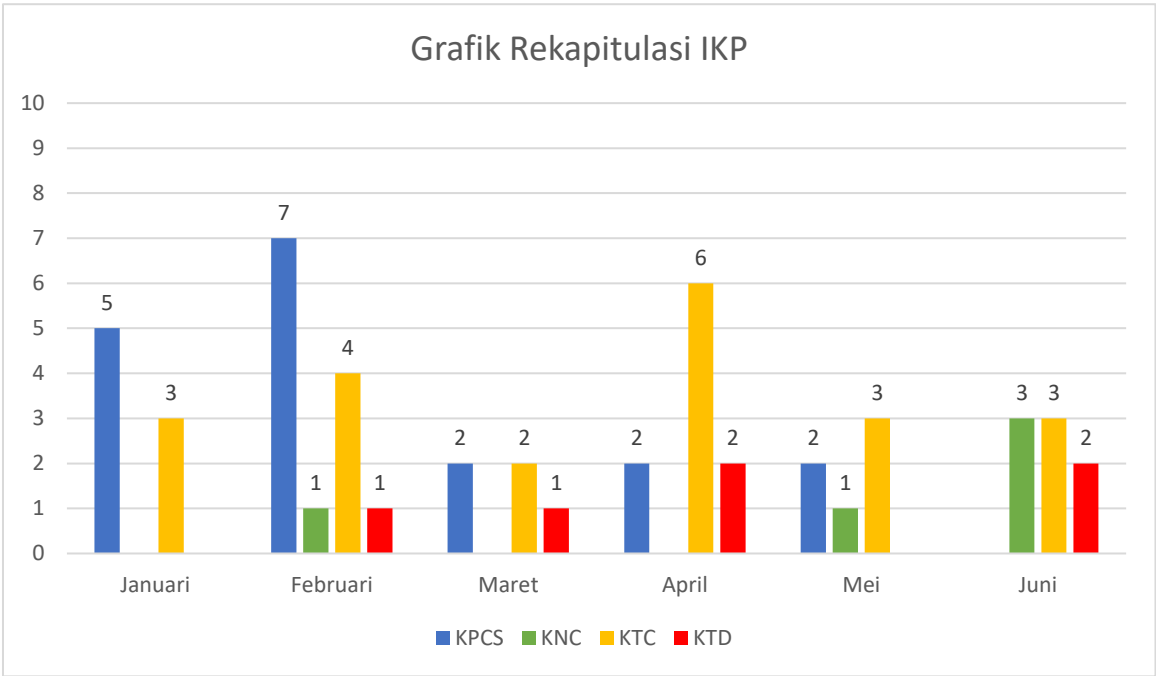
| No. | Tanggal    | Kronologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IKP  | Grade | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | menyadari obat yang diberikan farmasi berbeda dengan obat yang diadvicedkan DPJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | 21/04/2026 | Kejadian penurunan kesadaran dan gangguan napas pasca operasi remove implant diduga dipicu krisis hipertiroid yang sebelumnya tidak teridentifikasi saat pengkajian praoperasi karena pasien memiliki riwayat hipertiroid namun tidak rutin berobat, sehingga pasien memerlukan perawatan intensif di ICU.                                                                                           | KTD  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penguatan pengkajian praoperasi sesuai SPO asesmen pra anestesi dan pra operasi melalui verifikasi ulang riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan, disertai peningkatan komunikasi dan koordinasi antar DPJP, dokter anestesi, perawat, dan pasien/keluarga guna meminimalkan risiko komplikasi perioperatif.</li> </ul>                          |
| 7.  | 22/04/2026 | Bidan memberikan premed ondansentron padahal DPJP tidak memberi advice tersebut. Kemudian muncul bentol-bentol di tangan pasien akibat reaksi alergi ondansentron sehingga pelaksanaan kuret ditunda                                                                                                                                                                                                 | KTD  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian alergi harus terkaji mulai awal, jika di awal belum terkaji, harus dikaji pada tahap selanjutnya.</li> <li>- Memberikan pertanyaan terbuka jika bertanya ke bidan lain mengenai premed yang diberikan. Bidan juga harus meningkatkan fokus dan tidak memberikan tanggapan dengan mengangguk saja.</li> <li>- Melihat kembali advice DPJP di WA sebelum memberikan asuhan pada pasien.</li> </ul> |
| 8.  | 23/04/2026 | Kesalahan penyiapan obat karena petugas tidak teliti konversi dosis sesuai obat yang tersedia sehingga jumlah obat kurang                                                                                                                                                                                                                                                                            | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengkajian resep dan konversi dosis sesuai resep.</li> <li>- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check).</li> <li>- Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE</li> </ul>                                                        |
| 9.  | 24/04/2026 | Kesalahan penyiapan obat diawali dari DPJP tidak teliti dalam menginput resep, kemudian sudah direvisi namun petugas tidak teliti menyiapkan obat yang seharusnya diberikan sebanyak 60 tablet, hanya diberikan sebanyak 30 tablet. Lalu apoteker melakukan identifikasi pasien dan melakukan double check etiket dan obat dengan resep namun tidak teliti melihat kesesuaian resep dan jumlah obat. | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan komite medik</li> <li>- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check).</li> <li>- Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE</li> </ul>                                                                                     |
| 10. | 29/04/2026 | Kesalahan penulisan SBAR karena perawat langsung mengcopy paste advice DPJP tanpa melihat identitas pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPCS | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM</li> <li>- Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. | 06/05/2026 | Sonde pasien tidak ber-etiket karena adanya perubahan diit mendadak sehingga petugas gizi memberikan sediaan sonde yang dibawa dan belum diberikan label.                                                                                                                                                                                                                                            | KPCS | Biru  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Larangan menaruh sonde tanpa etiket di nurse station meskipun untuk sementara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Tanggal    | Kronologi                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKP  | Grade | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | 07/05/2026 | Lantai basah di depan UPS CT Scan bersumber dari tetesan sisa genangan air di ember alat AC yang ada di atas troli alat AC setelah melakukan pencucian di ruang operasi.                                                                                                       | KPCS | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghubungi CS untuk segera mengepel genangan air</li> <li>- Melakukan double check setiap selesai melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 13. | 09/05/2026 | Kesalahan Input E-Resep oleh DPJP dan Kesalahan Penulisan Etiket Obat racikan puyer tertera rute topikal dan cara penggunaan dioleskan.                                                                                                                                        | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan komite medis</li> <li>- Menegur staf yang bersangkutan dan sosialisasi kembali SPO pengkajian resep.</li> <li>- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check).</li> </ul>                                                                                                   |
| 14. | 16/05/2026 | Terjadi kesalahan interpretasi instruksi dokter terkait pemeriksaan laboratorium ulang, sehingga terdapat pemeriksaan yang dilakukan kembali di ruang rawat inap padahal instruksi tersebut telah ditujukan untuk pelaksanaan di IGD.                                          | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggantian biaya laboratorium oleh perawat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | 24/05/2026 | Terjadi kesalahan pemberian diet pada pasien, di mana instruksi diet cair Diabetasol oleh DPJP pada pagi hari tidak sesuai dengan pesanan diet yang dibuat oleh ahli gizi menjelang siang, sehingga pasien hampir menerima diet cair sonde yang tidak sesuai saat makan siang. | KNC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahli gizi bisa melihat operan pasien atau cppt untuk mengetahui diet yang di advice kan dpjp</li> <li>- Ahli gizi bisa lebih teliti lagi dalam memberikan jenis Diet kepada pasien</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 16. | 29/05/2026 | Ditemukan benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu)                                                                                                                                                                                                                   | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemorsian snack dilakukan minimal 1 jam sebelum di bagikan tidak boleh H-1 sebelum di bagikan</li> <li>- Setelah sudah diporsi dan di beri plastic wrap disimpan/diletakkan di tempat yang aman agar tidak ada benda asing yang masuk</li> <li>- Seperti makan pasien, snack juga harus di QC oleh ahli gizi sebelum di bagikan oleh penyaji</li> </ul> |
| 17. | 01/06/2026 | Kesalahan pemberian minuman (teh manis) untuk pasien dengan RPD DM sehingga gula darah pasien naik.                                                                                                                                                                            | KTD  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketelitian saat membagikan snack dengan tetap melihat pemesanan diet</li> <li>- Melakukan crosscheck kepada perawat dan pasien/keluarga pasien mengenai riwayat penyakit sebelum membagikan snack/makanan pasien</li> </ul>                                                                                                                |
| 18. | 02/06/2026 | Kesalahan dosis pemberian obat, obat yang telah diberikan kepada pasien anak karen perawat tidak double check dan ternyata belum dioplos dan obat sudah dispuut full dosis yang                                                                                                | KTC  | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelaksanaan SPO 5 benar dalam pemberian obat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Tanggal    | Kronologi                                                                                                                                                  | IKP | Grade | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | seharusnya pasien hanya mendapatkan ¼ dosis dari sediaan.                                                                                                  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | 08/06/2026 | Kesalahan Pemberian Obat LASA (di etiket tertulis Codikaf 10 mg tetapi yang diberikan Codikaf 15 mg)                                                       | KTC | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghubungi pasien untuk crosscheck obat yang diterima, mengarahkan pasien untuk memberhentikan konsumsi Codikaf 15 mg dan mengirimkan Codikaf 10 mg.</li> <li>- Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE</li> </ul> |
| 20. | 08/06/2026 | Pasien double Nomor RM dikarenakan 2x daftar dengan penjamin yang berbeda dan salah satunya menggunakan APM.                                               | KNC | Biru  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoteker melaporkan kepada Kains untuk melakukan telusur apakah terjadi kesalahan pemberian obat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 21. | 10/06/2026 | Kesalahan penulisan SBAR dengan menambahkan advice dokter lain yang tidak seharusnya sehingga menyebabkan melena                                           | KTD | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketelitian dan melakukan double check sebelum mengisi form SBAR pasien</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| 22. | 16/06/2026 | Nyaris terjadi kesalahan pemberian diet untuk pasien dengan RPD DM tapi sejak awal tidak diberikan diet DM                                                 | KNC | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketelitian dengan melihat riwayat penyakit pasien ketika memberikan diet pasien</li> <li>- Double check riwayat penyakit pasien sebelum membagikan diet ke pasien secara langsung</li> </ul>                                                                                                                  |
| 23. | 20/06/2026 | Kesalahan pemberian diet karena ahli gizi tidak melihat hasil lab dengan GDS tinggi, seharusnya diberikan diet DM namun ahli gizi memberikan diet TKTP RG. | KTC | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganti diet menjadi diet DM</li> <li>- Mengedukasi keluarga tentang diet DM karen GDS tinggi</li> <li>- Meningkatkan ketelitian ahli gizi untuk melihat hasil lab pasien sebelum meresepkan diet</li> </ul>                                                                                                             |
| 24. | 29/06/2026 | Perawat shift pagi salah memberikan konfirmasi pemberian obat kepada perawat shift sore                                                                    | KNC | Hijau | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan telusur dan mengirimkan foto antara venax dan lovenox agar dapat dikonfirmasi perawat shift pagi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |

2.6 REKAP INSIDEN KESELAMATAN PASIEN TW II TAHUN 2026 RS PRIMA HUSADA MALANG BERDASARKAN JENIS KEJADIAN

|           | KPCS | KNC | KTC | KTD | SENTINEL | JUMLAH |
|-----------|------|-----|-----|-----|----------|--------|
| JANUARI   | 5    |     | 3   |     |          | 8      |
| FEBRUARI  | 7    | 1   | 4   | 1   |          | 13     |
| MARET     | 2    |     | 2   | 1   |          | 5      |
| APRIL     | 2    |     | 6   | 2   |          | 10     |
| MEI       | 2    | 1   | 3   |     |          | 6      |
| JUNI      |      | 3   | 3   | 2   |          | 8      |
| JULI      |      |     |     |     |          |        |
| AGUSTUS   |      |     |     |     |          |        |
| SEPTEMBER |      |     |     |     |          |        |
| OKTOBER   |      |     |     |     |          |        |
| NOVEMBER  |      |     |     |     |          |        |
| DESEMBER  |      |     |     |     |          |        |
| JUMLAH    | 16   | 6   | 22  | 6   |          | 50     |



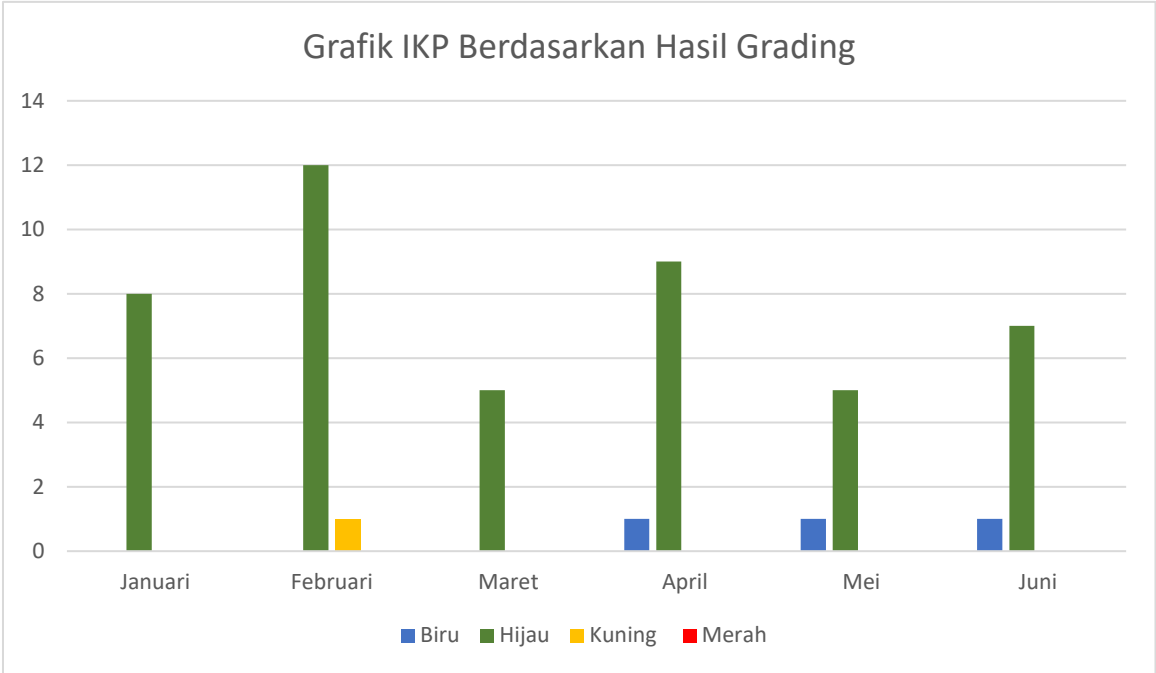
Berdasarkan data pelaporan insiden keselamatan pasien periode April–Juni 2026, tercatat sebanyak 24 insiden yang terdiri dari 4 Kejadian Potensial Cedera Signifikasn (KPCS), 4 Kejadian Nyaris Cedera (KNC), 12 Kejadian Tidak Cedera (KTC), dan 4 Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). Tidak terdapat kejadian sentinel selama periode pelaporan. Jenis insiden yang paling banyak dilaporkan adalah KTC (50%), sedangkan untuk KPCS, KNC, dan KTD masing-masing memiliki persentase yang sama yakni sebesar 16,67%.

Jumlah insiden yang dilaporkan pada Triwulan II menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien telah berjalan dan dimanfaatkan oleh staf sebagai sarana identifikasi risiko serta pembelajaran untuk perbaikan sistem pelayanan. Dominasi kejadian KTC, KNC, dan KPCS menunjukkan bahwa sebagian besar insiden

dapat terdeteksi sebelum menimbulkan dampak cedera serius pada pasien. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pengendalian risiko dan kewaspadaan petugas dalam proses pelayanan. Keberadaan 4 kasus KTD menunjukkan masih terdapat insiden yang menyebabkan dampak pada pasien sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar masalah dan menetapkan tindakan perbaikan yang efektif. Tidak ditemukannya kejadian sentinel merupakan hasil yang positif, namun bukan berarti risiko keselamatan pasien telah sepenuhnya terkendali. Setiap insiden yang terjadi tetap perlu dianalisis sebagai peluang perbaikan sistem guna mencegah terjadinya insiden dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Hasil analisis insiden menunjukkan pentingnya penguatan budaya keselamatan pasien, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta optimalisasi komunikasi efektif antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pembelajaran dari setiap insiden yang dilaporkan perlu disosialisasikan kepada unit terkait agar rekomendasi perbaikan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil pelaporan insiden Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa budaya pelaporan insiden di rumah sakit telah berjalan dengan baik. Meskipun tidak ditemukan kejadian sentinel, upaya peningkatan keselamatan pasien tetap perlu difokuskan pada pencegahan terulangnya KTD, KTC, KNC, dan KPCS melalui penguatan sistem, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, serta tindak lanjut hasil investigasi insiden secara berkesinambungan.

**2.7 GRAFIK INSIDEN KESELAMATAN PASIEN TW II TAHUN 2026 RS PRIMA HUSADA MALANG BERDASARKAN HASIL GRADING IKP**



**Analisis:**

Selama bulan April sampai Juni Tahun 2026 terdapat 3 insiden dengan grading biru, 21 insiden grading hijau, dan tidak ada insiden dengan grading kuning dan merah. • Dominasi insiden dengan grading hijau menunjukkan bahwa sebagian besar insiden yang terjadi memiliki tingkat risiko rendah hingga sedang dan memerlukan investigasi sederhana serta tindak lanjut perbaikan di tingkat unit.

Adanya 3 insiden dengan grading biru menunjukkan masih terdapat kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar apabila tidak segera dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Tidak ditemukannya insiden dengan grading kuning dan merah menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tidak terdapat insiden dengan tingkat risiko tinggi maupun ekstrem yang memerlukan investigasi komprehensif atau analisis akar masalah secara mendalam.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengendalian risiko keselamatan pasien di rumah sakit telah berjalan cukup baik, namun tetap diperlukan upaya identifikasi dan mitigasi risiko secara berkelanjutan untuk mencegah peningkatan tingkat keparahan insiden. Setiap insiden yang dilaporkan, termasuk insiden dengan grading hijau dan biru, perlu ditindaklanjuti melalui pembelajaran organisasi dan implementasi rekomendasi perbaikan guna mencegah kejadian berulang.

2.8 GRAFIK INSIDEN KESELAMATAN PASIEN TW II TAHUN 2026 RS PRIMA HUSADA MALANG

1. Sentinel



**Analisis:**  
Berdasarkan data IKP Sentinel Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat kejadian sentinel di Rumah Sakit Prima Husada Malang selama periode Januari hingga Juni 2026. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan program keselamatan pasien, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan dan prosedur operasional telah berjalan dengan baik. Ketiadaan kejadian sentinel mengindikasikan bahwa selama periode tersebut tidak terjadi insiden yang menyebabkan kematian, cedera permanen, maupun cedera berat yang tidak berkaitan dengan kondisi atau perjalanan penyakit pasien. Selain itu, capaian ini mencerminkan efektivitas upaya identifikasi, pencegahan, dan pengendalian risiko yang telah diterapkan di lingkungan rumah sakit. Meskipun demikian, upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien perlu terus dilakukan melalui penguatan budaya keselamatan, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, optimalisasi pelaporan insiden, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan guna mempertahankan capaian yang telah diperoleh dan mencegah terjadinya kejadian sentinel pada periode berikutnya.

2. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

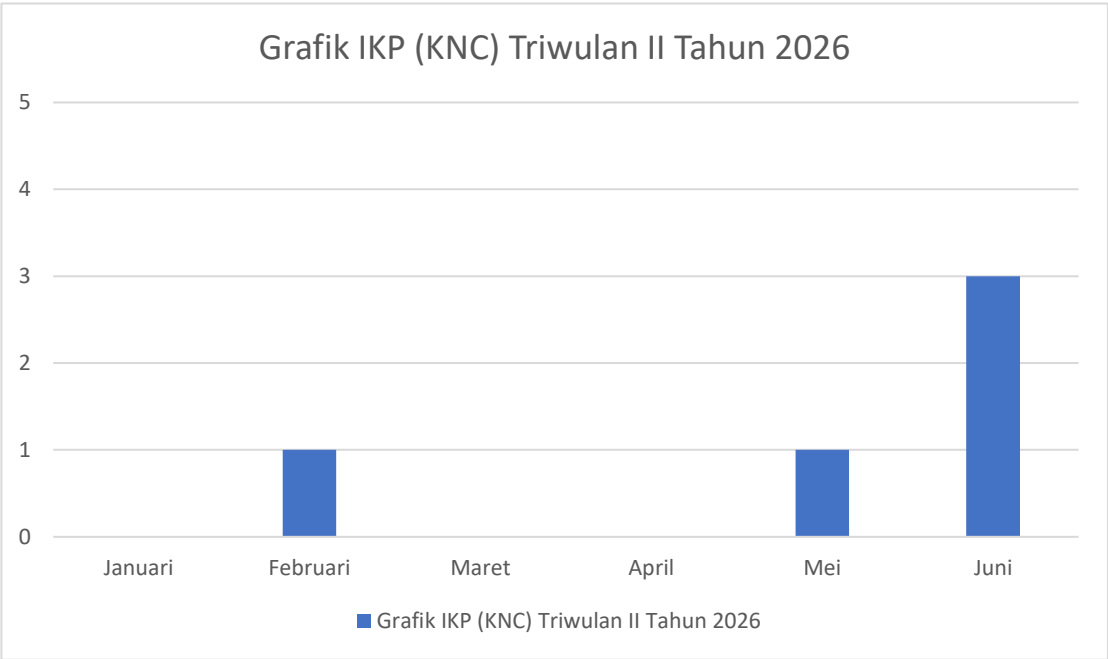


**Analisis:**



Berdasarkan grafik IKP KTD Triwulan II Tahun 2026, pada bulan April-Juni mengalami fluktuasi, di mana terjadi 2 insiden di bulan April dan 2 insiden di bulan Juni yang semuanya merupakan bands hijau. Tidak terdapat KTD pada bulan Mei. Jumlah kejadian ini mengalami peningkatan dari periode sebelumnya (Triwulan I) di mana insiden KTD yang terjadi sebanyak 2 insiden. Meskipun jumlah KTD pada Triwulan II meningkat dibandingkan Triwulan I, seluruh kejadian yang terjadi termasuk dalam grading hijau, sehingga tingkat risiko yang ditimbulkan relatif rendah dan dapat ditangani melalui investigasi sederhana serta tindak lanjut di tingkat unit. Tidak adanya KTD pada bulan Mei menunjukkan bahwa kejadian KTD belum terjadi secara konsisten setiap bulan, namun masih terdapat potensi risiko yang perlu diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah kejadian berulang. Seluruh kejadian KTD yang dilaporkan perlu dianalisis untuk mengetahui faktor penyebab yang mendasari, baik yang berkaitan dengan faktor manusia, komunikasi, kepatuhan terhadap prosedur, maupun sistem pelayanan. Peningkatan jumlah KTD dapat mencerminkan dua hal, yaitu meningkatnya kejadian yang perlu menjadi perhatian atau meningkatnya kesadaran petugas dalam melaporkan insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap karakteristik masing-masing insiden. Tidak ditemukannya KTD dengan grading biru, kuning, maupun merah menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap pasien masih dalam kategori rendah, namun upaya pencegahan tetap perlu dilakukan agar tidak berkembang menjadi insiden dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Hasil analisis KTD perlu disosialisasikan kepada unit terkait sebagai bahan pembelajaran bersama dan dasar penyusunan tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden serupa.

3. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)



Analisis:

Berdasarkan grafik IKP KNC Triwulan II Tahun 2026, pada periode April–Juni terdapat 4 kejadian KNC, yaitu 1 kejadian pada bulan Mei dan 3 kejadian pada bulan Juni, sedangkan pada bulan April tidak ditemukan kejadian KNC. Jumlah ini meningkat dibandingkan Triwulan I Tahun 2026, di mana hanya terdapat 1 kejadian KNC yang terjadi pada bulan Februari.

Peningkatan jumlah KNC menunjukkan adanya lebih banyak kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera namun berhasil dicegah sebelum mencapai pasien atau sebelum menimbulkan dampak klinis. Hal ini dapat mengindikasikan meningkatnya kewaspadaan petugas dalam mengidentifikasi dan melaporkan insiden keselamatan pasien.

KNC merupakan salah satu indikator penting dalam sistem keselamatan pasien

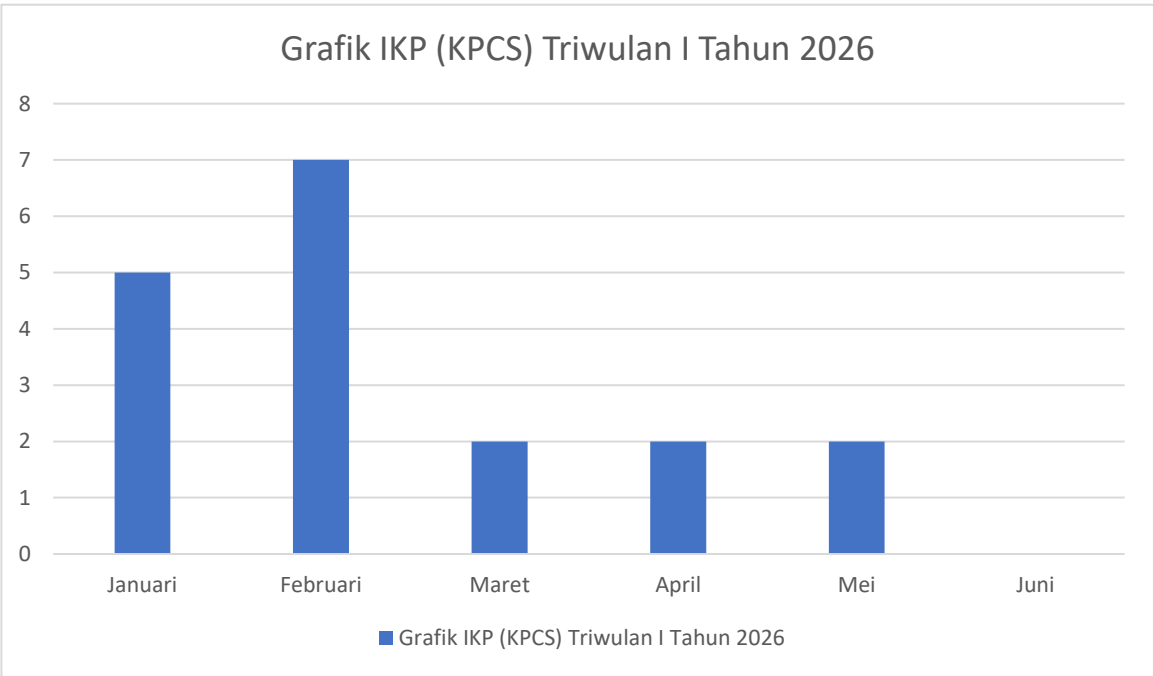


karena memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan pembelajaran dan perbaikan sebelum terjadi insiden yang menyebabkan cedera. Oleh karena itu, setiap kejadian KNC perlu dianalisis untuk mengidentifikasi faktor penyebab, baik yang berkaitan dengan manusia, metode kerja, komunikasi, lingkungan kerja, maupun sistem pelayanan.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah KNC dibandingkan periode sebelumnya, tidak adanya dampak cedera pada pasien menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian risiko dan deteksi dini masih berjalan efektif. Namun demikian, rumah sakit tetap perlu melakukan tindak lanjut terhadap setiap kejadian yang dilaporkan guna mencegah terulangnya kejadian serupa dan mengurangi potensi berkembangnya KNC menjadi KTD atau insiden dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, pelaporan KNC pada Triwulan II Tahun 2026 mencerminkan adanya budaya pelaporan insiden yang cukup baik serta komitmen tenaga kesehatan dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui identifikasi risiko secara proaktif.

4. Kejadian Potensial Cedera Signifikan (KPCS)



Analisis:

Berdasarkan grafik IKP KPCS Triwulan II Tahun 2026, terdapat 4 insiden KPCS, yaitu 2 insiden pada bulan April dan 2 insiden pada bulan Mei, sedangkan pada bulan Juni tidak ditemukan kejadian KPCS. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan Triwulan I Tahun 2026, di mana tercatat 14 insiden KPCS.

Penurunan jumlah KPCS menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya identifikasi dan pengendalian risiko di lingkungan rumah sakit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera pada pasien semakin berkurang melalui penerapan langkah-langkah pencegahan dan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan.

Meskipun KPCS belum menimbulkan dampak langsung kepada pasien, kejadian ini tetap perlu mendapat perhatian karena menggambarkan adanya kondisi yang berpotensi menyebabkan insiden apabila tidak segera dikendalikan. Oleh karena itu, setiap KPCS yang terjadi perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi sumber risiko dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat.

Tidak ditemukannya KPCS pada bulan Juni menunjukkan adanya perbaikan yang perlu dipertahankan melalui pengawasan rutin, peningkatan kesadaran staf terhadap keselamatan pasien, serta pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil investigasi insiden yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, penurunan jumlah KPCS pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan indikator positif yang menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko dan penerapan budaya keselamatan pasien. Namun demikian, upaya

---

identifikasi risiko, pelaporan insiden, dan implementasi tindakan perbaikan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah terjadinya insiden yang lebih serius di masa mendatang.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian laporan Insiden Keselamatan pada Triwulan II Tahun 2026 di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan saat ini, terutama upaya angka kejadian KTD / KTC / KNC / KPCS dapat ditekan dan kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat / unit yang sama maupun di tempat / unit yang lain di rumah sakit Prima Husada Malang, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Mengetahui,  
Direktur RS Prima Husada Malang



**dr. Resti Lestantini, M.Kes**

Malang, 20 Juli 2026

Penyusun,  
Ketua Komite PMKP

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diah Puspita Rifasanti'.

**dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M**